

INDICADO POR: Drº Keffel Fernandes

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

TAKASHI KATAHIRA

IDADE: 78 PESO: 635 ALTURA: 163 PROFISSÃO: médico Ortopedista

SINTOMAS: Dor de cabeça / durante o dia sonolência

QUEIXAS: Sono interrompido às 04hs.

MEDICAMENTOS: Pesquisa de crise hipertensiva /

MÉDICO: Drº Sampaio (geriatria)

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: não faz

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S

ALMOÇO: S

LANCHE: S

JANTAR: S (19:30h)

HORA QUE DORME:

HORA QUE ACORDA:

COCHILO () S ☒ N SF DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ NFUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: 2X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI:

IAH: 49.1

SPO2: 68% / média

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: está esquecido 91%.

neuralgia do trigêmeo (fez craniotomia)

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

Relata que tem ↑ sensibili//

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

da hemiface (E)

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA coluna dorsal

(S) ORTOPÉDICA

() NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

04/08 já sofreu acidente de carro ao dormir ao volante há 3 anos

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório acentuado (49,1 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina preservada (68%);
3. Latência para o início do sono diminuída (1,0 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM (121,5 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (83,6 %) (VN= $\geq$ 85%);
6. Aumento do índice de despertares (30,1 n°/h) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 diminuída (1,9 %) (VN= 2% a 5%);
8. Aumento do percentual do estágio N2 (63,5 %) (VN= 45% a 55%);
9. Diminuição do percentual do estágio N3 ondas delta (7,0 %) (VN= 13% a 23%);
10. Aumento do percentual do estágio REM (27,6 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco constante verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

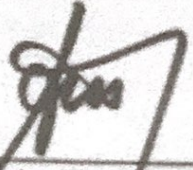
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentua

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: TAKASHI KATAHIRA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 19-06-2025

Idade: 78 anos

Peso: 63,5 kg

Altura: 1,63 m

Médico Solicitante: DR. KEFFEL ANTONIO PEREIRA
FERNANDES

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 19/06/2025 22:03 e finalizado às 20/06/2025 05:46.

A latência para início do sono foi de 1,0 min e a latência para o sono REM de 121,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 387,5 min, com eficiência do sono de 83,6 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 1,9 % de estágio N1, 63,5 % de estágio N2, 7,0 % de estágio N3 e 27,6 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 75,0 min. Ocorreram 233 despertares, sendo o índice de 30,1 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 317, sendo 178 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 139 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 49,1 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 47,1 e o IDR durante o sono NREM foi de 49,8. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 49,1 (nº/h), sendo 27,6 apneia/h e 21,5 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 93%, a média de 91% e a mínima de 68%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 38,3 (nº/h), sendo que em REM foi de 41,5 (nº/h) e em NREM foi de 47,5 (nº/h). Permaneceu 22,0 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.